

CONDUITE A TENIR FIEVRE AIGUE RECENTE

DR BENSOUICI

I/INTRODUCTION:

- La fièvre est **élévation pathologique** de la température corporelle $\geq$ de 38 °C.
- Symptôme **fréquent** en consultation
- On distingue:

➤ **Fièvre aiguë récente < à 5 jours**

➤ Fièvre de durée intermédiaire 5 à 10 jours

➤ Fièvre persistantes ; au long cours > 20 jours

- Toute fièvre **aigue est une urgence** jusqu'à preuve du contraire
- Souvent d' étiologie infectieuse+++

Il faut Rechercher les **signes de gravité** nécessitant une prise en charge urgente

Important:

- **Maître symptôme d'infection**
- **Certaines infections ,toxi-infections la température est normale: Choléra,Tétanos,botulisme**
- **Le choc septique à BGN peut être associé à une hypothermie**
- **Non infectieuse**

II/PHYSIOPTHOLOGIE

Hypothalamus est le centre principal de régulation de la température centrale « thermostat »

Fièvre 



Modification du centre thermorégulateur hypothalamique qui s'équilibre à un niveau plus élevé que normalement

Pyrogènes exogènes → les produits bactériens :

toxines

endotoxines(ex. : lipopolysaccharide des Gram –)

exotoxines des Gram+



Stimulent les **cellules immunitaires** (macrophages, monocytes, polynucléaires, lymphocytes....)



libèrent des **pyrogènes endogènes** :

interleukine (IL-1),TNF- α , interféron...



Stimulation hypothalamique



↑ **PGE2** → modification de la régulation thermique(s'équilibre à un niveau plus élevé que normalement) =L'hypothalamus considère la température normale « trop basse » :



Activation des mécanismes de thermogenèse (Vasoconstriction + frissons + ↑ métabolisme)



↑ Température corporelle (fièvre)



Renforcement de la réponse immunitaire



Élimination du pathogène



↓ Cytokines → ↓ PGE2 → Retour à la normale

III/DIAGNOSTIC POSITIF:

- Fièvre si température **> 38°C** le matin et **>38°3** le soir
- Fébricule est une température comprise entre 37,5 et 38°C
- Les chiffres de température obtenus par voie **buccale** ou **axillaire** doivent être augmentés de **0,5°C** pour évaluer la température centrale,
- Mesure de la température: à distance des repas après un repos de 20 minutes

NB:T normale =37,5°C le matin et 37,8 °C le soir

DIAGNOSTIC POSITIF

- Les fièvres aiguës récente < 5 jours
- Les fièvres de durée intermédiaire 5 - 20 jours
- Les fièvres persistantes ou au long cours ou
- prolongées > 20 jours

SIGNES DE GRAVITE:

➤ **Signes de sepsis** dans un contexte d'une infection ou suspicion d'infection:

Neurologique: angoisse, agitation, confusion, troubles du comportement, coma.

Cardiovasculaire : Hypotension $TAS \leq 100$, froideur des extrémités, tachycardie, cyanose, marbrures

Respiratoire: Détresse respiratoire: Polypnée, signes de lutte, $Spo_2 < 90\%$

Hémostase : saignement en nappe, purpura, ischémie des extrémités

Hépatique : ictère, encéphalopathie, insuffisance hépatocellulaire,

Rénale: oligurie inf 0,5ml/kg/h, anurie

Score d'évaluation rapide

CAT:

- q SOFA ≥ 2 :sepsis
- état d'évolution péjorative mortalité 10%
- il faut:
 - **hospitalisation du patient** ,compléter score SOFA
 - Gaz du sang et lactates
 - prendre des mesures de monitoring de la pression artérielle
 - trt symptomatique +++et antibiothérapie probabiliste IV
 - Contacter le réanimateur,

➤ Dépister les terrains à risque d'évolution grave:

- **Nourrisson et enfants inférieur à 4 ans** :risque de convulsions hyperthermiques et /ou déshydratation
- **Sujet agé**: déshydratation –trouble du comportement
- **Femme enceinte**: souffrance/mort foetale -fausse couches – accouchement prématuré
- **Immunodépressions:**
 - *neutropénie, splénectomie risque d'infections bactériennes graves voir fatales → antibiothérapie urgente si fièvre+++
 - *Autres déficits de l'immunité cellulaire ou humorale: HIV, myelome...
 - *Traitement immunosuppresseur ,corticothérapie ,biothérapie...

Dépister les terrains à risque d'évolution grave:

- **Comorbidités:**
 - diabète mal équilibré
 - insuffisance cardiaque ,coronopathie
 - insuffisance respiratoire
 - insuffisance rénale chronique
 - cirrhose

IV/DIAGNOSIC ETIOLOGIQUE:

□ ENQUETE ETIOLOGIQUE:

- Interrogatoire
- Examen clinique
- Les examens complémentaires

□ ETIOLOGIES

***Interrogatoire :**

- **Age ,sexe**
- **Etat vaccinal**
- **Profession, loisirs**
- **Notion de contagage**
- **Comorbidité**
- **Prise médicamenteuse : ATB , anti pyrétiques, AINS...**
- **Comportement à risque: sexuel, toxicomanie,,...**
- **Voyage récent**
- **Matériel prothétique**
- **Cathéter vasculaire**
- **Contexte post-opératoire**

*Examen physique : rigoureux app/app

La fièvre étant authentifiée

- **Neurologique:** syndrome méningé, déficit neurologique
- **Cardiaque:** souffle
- **Abdominal :** diarrhée, défense, HPM,SPM
- **Pulmonaire:** signes fonctionnels, percussion, auscultation
- **Cutané:** ictère, purpura, plaie , éruption ,escarre d'inoculation
dermohypodermite,,,
- **ORL:** angine , douleur des sinus, tympan
- **Ostéo-articulaire:** impotence fonctionnelle
- **Génito-urinaire:** leucorrhées, signes fonctionnels urinaires, BU
- **Ganglionnaire**
- **Matériel étranger :** sonde urinaire ,KT , prothèse,,

***les examens complémentaires:**

Orientation:

- FNS
- CRP
- Procalcitonine
- Bilan rénal ;glycémie,
- Si signes de gravité: TP, fibrinogène , gazométrie , lactates

Examen physique

- **Compléter l'examen par les touchers pelviens**
- **Chimie des urines**
- **Radiographie pulmonaire**

Certitude:

- Hémocultures ,
- Autres prélèvements à visée microbiologique selon le contexte:
 - Ponction lombaire
 - ECBU
 - Prélèvement de pus
 - ponction de pleurésie, d'ascite
 - coprologie des selles :ED
 - frotti de sang et goutte épaisse

Examens radiologiques orientés selon les examens clinico-biologiques

Echographies abdominale , parties molles

échocardiographie

TDM,,,,

Exemples: examens complémentaires guidés par la situation clinique

- **Syndrome méningé ou coma fébrile** → PL ,TDM cérébrale
- **Purpura fulminans**
→ ponction lombaire+/- , hémocultures trt urgent à domicile+++
- **Sepsis +/- signes d'insuffisance circulatoire aigue**
→ hémocultures , porte d'entrée
- **Paludisme grave/ neuropaludisme**
→ frottis, goutte épaisse
- **Dermohypodermite nécrosante , gangrène gazeuse**
→ hémocultures , prélèvements
- **Lombalgies fébriles** → echo rénale , ECBU, hémocultures
- **Ictère fébrile** → echo abdominale, hémocultures
- **Abdomen aigu fébrile** → urgence chirurgicale, echo ou scanner abdominal et hémocultures

Situations où les examens complémentaires ne sont pas indiqués:

- Infection bactérienne focalisée :évidente cliniquement ,non compliquée, accessible à une ATB probabiliste: **otite ,sinusite angine streptococcique ,érysipèle**
- Tableau viral bénin bien toléré :**virose saisonnières** ,fièvres éruptives infantiles , bronchite aigue

Les étiologies

❑ Urgentes:

- Purpura fulminans
- Sepsis /choc septique
- Méningite purulente
- Méningite aiguë à liquide clair(herpétique)
- Endocardite
- Fasciite nécrosante
- Paludisme grave

URGENCE THERAPEUTIQUE

Principales étiologies urgentes et traitements:

infection	traitement
Purpura fulminans	Ceftriaxone ou Céfotaxime IV
Sepsis/Choc septique	Ceftriaxone ou Céfotaxime IV
Méningite purulente	Ceftriaxone ou Céfotaxime IV
Méningo-encéphalite herpétique	Aciclovir IV
Paludisme grave	Artésunate IV

Antibiothérapie probabiliste **urgente** devant une **fièvre sans diagnostic précis**:

- **Neutropénie**
- **Asplénie**
- **immunodépression**
- **Décompensation d'une comorbidité**

❑ Causes moins urgentes

Infections bactériennes focalisées :

- Pneumonie PFLA,
- Pyélonéphrite
- intra abdominale : cholécystite , appendicite...
- génitale
- Cutanée: dermohypodermite non nécrosante; érysipèle
- osseuse
- ORL:otite ,sinusite, angine streptococcique ,

❑ Non urgentes :Virose aiguë (grippe)

- Apanage de l'enfant , adolescent, adulte jeune
- Fièvre isolée, bien tolérée,
- Signes d'imprégnation virale:arthromyalgies;catharre oculaire , nasal, respiratoire et digestif
- Aucun examen complémentaire n'est nécessaire
- **Pas d' Antibiotiques +++**
- Guérit spontanément en moins d'une semaine

Femme enceinte	PNA, listériose, toxo et rubéole
Sujet âgé	infections pulmonaires, urinaires et digestives
Diabète	plaie
Valvulopathie, prothèse valvulaire	Endocardite infectieuse
Opéré	Infections du site opératoire
Cirrhose	S.pneumoniae, infection du liquide d'ascite
Asplénie	S.pneumoniae, méningo, HI
VIH	S.pneumoniae, Infections opportunistes
Séjour en zone d'endémie palustre	paludisme

Etiologies non infectieuses

- **Contexte lésionnel** : chirurgie majeure, hémorragie méningée, hématome volumineux ...
- **Accident thromboembolique**
- **Causes inflammatoires**: lupus, Crohn, PAN
- **Néoplasie**: Hémopathie maligne, kahler
- **Coup de chaleur**
- **Causes médicamenteuses**: syndrome malin des neuroleptiques
- **Endocrinopathies**: hyperthyroïdie, phéochromocytome

V/Traitement symptomatique

- **Antipyrétique**: non systématique
- Indications: fièvre mal tolérée,
terrain particulier(nourrisson, sujet âgé, i insuffisant cardiaque ,
respiratoire)
Paracétamol : 15 mg/kg4x/j chez enfant
1g 4x/j chez adulte
- **CI**: Hépatite et insuffisance hépatique
- **AINS et aspirine** : non recommandés
- **Méthodes physiques** : humidification de l'atmosphère, couvertures humides
- **Lutter contre la déshydratation+++**

En résumé.....

